

แถลงการณ์ เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า

ด้วยในปัจจุบันมีหลักฐานทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ชัดเจนด้วยข้อมูลและผลทางห้องทดลองว่าบุหรี่ทั้งที่เป็นบุหรี่มวนที่มีขายทั่วไป และบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทผู้ผลิตยาสูบพยายามทำการตลาดเพื่อมุ่งเป้าไปที่เยาวชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนบุหรี่ธรรมดา โดยการใช้อิทธิพลทางการตลาดเข้าถึงวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งจากการทำการตลาดอย่างเข้มข้นโดนใจวัยรุ่น และการแทรกแซงนโยบายของรัฐ lobby ผู้มีอำนาจหรือกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจทางการเมืองในการกำหนดนโยบายของรัฐให้มีการเปิดตลาดการค้าเสรีของผลิตภัณฑ์ยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งการให้ข้อมูลเท็จหรือไม่สมบูรณ์ครบถ้วน มุ่งแต่จะให้ข้อมูลที่เป็นคุณและเกิดผลประโยชน์แก่ผลิตภัณฑ์ การทำกำไร สร้างความเข้าใจผิดในกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ทำการตลาดมีดผิดกฎหมาย โดยที่ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติและประกาศกระทรวง และหน่วยงานรัฐ ถึง 4 ฉบับ กำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้า ส่งผ่าน ผลิต จำหน่าย จำเริญในประเทศไทย อย่างชัดเจนอยู่แล้วก็ตาม ประกอบกับกระบวนการรักษากฎหมายขาดความเข้มงวดในการบังคับใช้ ทำให้เกิดการแพร่หลายของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชน

จากผลการตรวจพบทางวิทยาศาสตร์ พบว่าบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า มีองค์ประกอบที่เป็นสารพิษทำลายสุขภาพอยู่หลายชนิด ทั้งเป็นยาเสพติดรุนแรง มีผลเรื้อรังระยะยาว สารก่อมะเร็ง สารทำลายระบบการหมุนเวียนโลหิตและการทำงานของสมองและหัวใจ ตลอดจนอวัยวะอื่นๆทั่วร่างกายมีผลในระยะยาวถึงชีวิตหรือพิการ ผลที่เกิดขึ้นได้เกิดกับผู้สูบบุหรี่นั้น ยังมีผลต่อการปนเปื้อนในอากาศทั้งก๊าซพิษและสารเคมีมีผลต่อผู้ใกล้ชิดได้รับควันบุหรี่มือสองและมือสาม ซึ่งถ้าได้รับในปริมาณสูงและเป็นเวลานานจะมีผลอันตรายต่อสุขภาพของร่างกาย เช่นเดียวกับผู้สูบบุหรี่เอง

องค์ประกอบร่วมระหว่างบุหรี่มวนที่ผลิตจากใบยาสูบ โดยได้ควันจากการจุดสูบ กับบุหรี่ไฟฟ้าที่ผลิตจากการสกัดเอานิโคตินจากใบยาสูบมาให้ความร้อนจากแบตเตอรี่ ทำให้เกิดไอระเหยสูดเข้าสู่ปอด คือสารเคมีที่ชื่อ “นิโคติน” ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นสารเสพติดและมีผลทำให้เกิดการอักเสบของเส้นเลือดเมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบการหมุนเวียนโลหิต ทำให้เส้นเลือดตีบและอุดตัน เลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงอวัยวะของร่างกายได้ตามปกติ

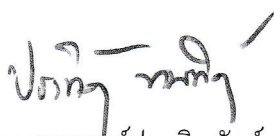
จากอันตรายที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ของการได้รับควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านี้ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการบริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่างๆ รวมทั้งระบบหายใจ ระบบหัวใจ สมอง ไต และอื่นๆ ร่วมกับราชวิทยาลัยทางการแพทย์ และสุขภาพ จึงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่กระจายของบุหรี่ โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าในตลาดผิดกฎหมายของประเทศไทย ประกอบกับความเห็นและประกาศขององค์กรทางสุขภาพที่สำคัญสูงสุดของโลกทั้ง 2 องค์กรคือ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) และแพทยสมาคมโลก (World Medical Association หรือ WMA) ได้ร่วมกันออกประกาศถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์นี้ต่อสุขภาพของ

ประชาชน ด้วยความห่วงใยและได้ขอความร่วมมือจากเครือข่ายแพทยสมาคมสมาชิกทั่วโลกให้ร่วมมือกันในการ
สกัดกั้นการเข้าถึงสารอันเป็นพิษของเยาวชน โดยเฉพาะทางสื่อต่างๆ และขอความร่วมมือเฝ้าระวังและสนับสนุนให้เกิด
งานวิจัยขนาดใหญ่เพื่อพิสูจน์ให้เห็นชัดถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และราชวิทยาลัยทางการแพทย์ และ สาธารณสุข จึงขอประกาศข้อมูล
ถูกต้องและขอความร่วมมือจากประชาชนและเยาวชนให้ละเว้นการใช้บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพ
ของตนเองและรักษาสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนของสารพิษในบรรยากาศ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ลดอัตราการเกิดโรค
ต่างๆที่เป็นผลต่อการได้รับสารนิโคตินต่อไป

พร้อมนี้ ได้แนบเอกสารประกาศขอความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก และแพทยสมาคมโลกมาเพื่อ
รับทราบโดยทั่วกัน

ด้วยความปรารถนาดี



(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประกิจพันธุ์ ทมทิศรงค์)

นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

WMA STATEMENT ON E – CIGARETTE: 15 DECEMBER 2023

E Cigarette Are Harmful and Not safe, warn Physician Leaders

แถลงการณ์ของแพทยสมาคมโลกเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า และระบบการนำส่งนิโคตินเข้าสู่ร่างกายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ENDS)

เอกสารนี้ เป็นการพัฒนาในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของแพทยสมาคมโลกในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ประเทศไทย และมีการปรับปรุงใหม่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของแพทยสมาคมโลก ประจำปี ๒๕๖๖ ที่เมือง Kigali ประเทศ Rwanda

หลักการ

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำส่งสารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีการสูดดม ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่เป็นตัวให้ความร้อน และตลับบรรจุนิโคตินเหลว ซึ่งเมื่อได้รับความร้อนจะกลายเป็นไอระเหยที่ถูกสูดเข้าสู่ปอด และพ่นออกมาที่ลมหายใจ ซึ่งอาจผลิตให้มีรูปร่างต่างๆ กันรวม ทั้งที่เป็นตุ๊กตาที่ยั่วยวนเยาวชนได้หรือเป็นรูปร่างคล้ายอุปกรณ์ที่ใช้ประจำวัน เช่น ปากกา และอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ (USB memory stick)

การได้รับนิโคตินมีผลต่อการพัฒนาของสมอง และนำไปสู่การติดยาเสพติด ซึ่งผู้ผลิตสามารถออกแบบและใส่ส่วนผสมที่แตกต่างกัน โดยไร้มาตรฐาน ขาดการรับรองคุณภาพ การศึกษาที่แสดงถึงระดับนิโคตินที่ให้เข้าสู่ผู้ใช้ และการดูดซึมยังมีน้อยมากซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน นอกจากนั้นยังมีส่วนประกอบอื่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารพิษ สารก่อมะเร็ง และสารโลหะหนักมากมาย

แม้ว่าผู้ผลิตและผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าจะอ้างว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดา แต่ยังไม่มีการศึกษาใด ที่สามารถสรุปได้ว่าไอระเหยของนิโคตินไม่เป็นอันตราย และไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง นอกจากนั้นยังมีข้อมูลว่ามีอันตรายต่อการเกิดมะเร็ง โรคทางเดินหายใจจากสารพิษต่างๆ ในไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าหลายชนิด ดังนั้นทางเลือกที่ปลอดภัยคือ คือ การงดการสูบบุหรี่ไฟฟ้า และระบบการนำนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย (ENDS) ทั้งหมด

ข้อมูลหลักฐานที่พบแล้วว่าบุหรี่ไฟฟ้า และ ENDS มีอันตราย และไม่ปลอดภัย คือ

- การสร้างรูปลักษณ์ และการทำการตลาดที่เข้าชวนเยาวชนและเด็ก โดยเฉพาะการใส่กลิ่น และรสที่เข้าชวนที่นำไปสู่การเสพติดนิโคติน และเป็นเส้นทางนำไปสู่การเสพติดสารอย่างอื่น และทำให้การเสพติดของเยาวชนมีเพิ่มขึ้น
- การกล่าวอ้างจากผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่จะเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาโดยไม่มีข้อมูลสรุปทางวิทยาศาสตร์ต่อผลการช่วยรักษา หรือ การหยุดสูบบุหรี่แต่ตรงกันข้ามกลับมีข้อมูลที่ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์นี้มีอันตรายต่อสุขภาพ และไม่ปลอดภัย
- ขาดข้อมูลการใช้ ขนาด การผลิต และ องค์ประกอบ นอกจากนั้นยังมีโอกาสผสมสารอื่นเข้าไปด้วย เช่น กัญชา และอาจเป็นผลให้มีการใช้ร่วมกันของบุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่ยาเสพติดด้วย
- มีโอกาสสูงที่เด็กจะได้รับพิษของนิโคตินทางการกิน หรือทางผิวหนัง เนื่องจากมีการขายทางอินเทอร์เน็ต และหีบห่อที่ไม่ปลอดภัยต่อเด็ก
- ก่อให้เกิดผลร้ายเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่เป็นโรค โควิด ๑๙

ข้อเสนอแนะ

๑. บุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่นำนิโคตินเข้าสู่ร่างกายต้องอยู่ภายใต้กติกากฎของ FCTC และอยู่ภายใต้กำหนดกฎหมายของ Smoke free Laws
๒. ผู้ผลิต และผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่นำนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย (ENDS) ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบ มีการควบคุมในฐานะผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หรือการบริหารยา โดยที่อย่างน้อยต้องมีการกำหนดความเข้มข้น ขนาดภาชนะบรรจุ มีฉลาก และรูปแบบบรรจุที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ให้รวมถึงนิโคตินที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วย
๓. มีการทำการทดลองขนาดใหญ่ที่ตรวจสอบดูส่วนประกอบของบุหรี่ไฟฟ้า และกระบวนการผลิตที่แสดงถึงอันตราย และความสามารถในการช่วยเลิกบุหรี่ยาเสพติดด้วย
๔. บุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่นำนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย (ENDS) ไม่สมควรให้ทำการตลาดว่าช่วยเลิกบุหรี่ยาเสพติดได้ ถ้าไม่มีการสนับสนุนจากงานวิจัยของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เหมาะสม โดยอาจต้องใช้การบรรจุในหีบห่อชนิดเรียบ (Plain packaging) ปราศจากการโฆษณาตามที่มีการประกาศไว้แต่เดิมของแพทยสมาคมโลก

๕. การโฆษณา การขาย การตลาดที่นำไปสู่การเข้าถึงของเยาวชน เป็นสิ่งต้องห้าม
๖. การผลิต การกระจาย และ การขายบุหรี่ไฟฟ้า แบบมีส่วนผสมของกลิ่นหอมหรือวัสดุใกล้เคียงเป็นสิ่งต้องห้าม
๗. การขายบุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์นำนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย (ENDS) ทางอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งต้องห้าม เพื่อป้องกันการเข้าถึงของเยาวชน
๘. แพทย์ กุมารแพทย์ และทันตแพทย์ ต้องช่วยกันแจ้งข้อมูลถึงอันตราย พิษภัย ของบุหรี่ไฟฟ้า และ ผลิตภัณฑ์นำนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย เช่น การเสพติด โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ และ โรคปอด การเสียหายต่อการพัฒนาของสมอง และอวัยวะต่างๆของร่างกาย ถึงแม้ว่าผลจากการวิจัยจะยังไม่สามารถปรากฏได้ชัด
๙. แพทยสมาคมโลก และ แพทยสมาคมในประเทศสมาชิกต่างๆ ต้องสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์นำนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย (ENDS) โดยเฉพาะใน เด็ก เยาวชน และหนุ่มสาว

แปลโดย นายแพทย์ วันชาติ ศุภจัตุรัส อดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (๒๕๕๓-๒๕๕๕) และ อดีตนายกแพทยสมาคมโลก (ค.ศ.2010)

Ref. Statement on Electronic Cigarettes and Other Electronic Nicotine Delivery Systems. WMA

WMA STATEMENT ON ELECTRONIC CIGARETTES AND OTHER ELECTRONIC NICOTINE DELIVERY SYSTEMS



Adopted by the 63rd WMA General Assembly, Bangkok, Thailand, October 2012 and revised by the 74th WMA General Assembly, Kigali, Rwanda, October 2023

PREAMBLE

Electronic cigarettes (e-cigarettes) and other electronic nicotine delivery systems (ENDS) are products designed to deliver nicotine to a user in the form of an aerosol. These products are usually composed of a mouthpiece, a rechargeable battery-operated heating element, a replaceable cartridge that contains liquid nicotine and/or other chemicals, and an atomizer that, when heated, turns the contents of the cartridge into an aerosol. This aerosol is then inhaled by the user and exhaled. These products are often made to look like other tobacco-derived products like cigarettes, cigars, pipes, toys and electronics that appeal to young people. They can also be made to look like everyday items such as pens and USB memory sticks. ENDS and their risks are outlined in more detail in the [WMA Statement on Health Hazards of Tobacco Products and Tobacco- Derived Products](#).

Nicotine exposure, no matter how it is delivered, can affect brain development and lead to addiction. No standard definition of e-cigarettes exists, and manufacturers use different designs and different ingredients. Quality control processes used to manufacture e-cigarettes are substandard or non-existent, and few studies have been done to analyze the level of nicotine delivered to the user and the composition of the aerosol or vapor produced. Unknown amounts of nicotine are delivered to the user, and the level of absorption is unclear, leading to potentially toxic levels of nicotine in the system, especially in children, adolescents and young adults. E-cigarettes and ENDS may also contain other ingredients toxic or carcinogenic to humans including delivery solvents, propylene glycol, glycerin, pulegone, formaldehyde, acetaldehyde, acrolein, and heavy metals, such as chromium, copper, zinc, tin and lead.

Manufacturers and marketers of e-cigarettes and ENDS often claim that use of their products is a safe or safer alternative to smoking cigarettes, particularly since e-cigarettes and ENDS do not produce carcinogenic smoke. However, no studies have conclusively determined that the aerosol is not toxic or carcinogenic.

There is some evidence of a risk of carcinogenicity of the respiratory tract due to long-term, cumulative exposure to nitrosamines and to acetaldehyde and formaldehyde. As with tobacco products, the safest option is to abstain from using e-cigarettes and ENDS.

Evidence already exists that e-cigarettes and ENDS are harmful and not safe. Risks include:

- appeal to children, adolescents and young adults, through packaging and marketing designed to appeal to these age groups, and especially when flavors like strawberry or chocolate are added to the cartridges. These factors can increase nicotine addiction among young people, and may be a gateway to experimenting with other tobacco products. Packaging and marketing targeted to young people has contributed to the dramatic increase in e-cigarette and ENDS use which in some regions is more popular than tobacco smoking.
- the belief promoted by manufacturers that these devices are acceptable alternatives to scientifically proven cessation techniques, when neither their value as therapeutic aids for smoking cessation nor their safety as cigarette replacements is established. Evidence reveals that these products are harmful to health and not safe. In addition, evidence on the use of ENDS as a way to decrease tobacco use in adults is inconclusive;
- inconsistent and unknown dosage, manufacturing processes, and ingredients, including the potential for abusing or manipulating the product, e.g., by adding cannabis, and simultaneous use with other tobacco products (dual or poly use);
- high potential of toxic exposure to nicotine by children, either by ingestion or dermal absorption from contents of a nicotine cartridge, because the cartridges and refill liquids are readily available over the Internet and are not always sold in child resistant packaging;
- worse clinical outcomes in patients with the SARS-COV2 virus who also use e-cigarettes.

RECOMMENDATIONS

1. That e-cigarettes and ENDS be subject to the WHO Framework Convention on Tobacco Control, and to jurisdictional smoke-free laws and regulations.
2. That the manufacture and sale of e-cigarettes and ENDS be subject to national regulatory bodies as either a new form of tobacco product or as a drug delivery device. At a minimum, regulations should address maximum strength of nicotine fluids, tank size on vaping devices, product labeling, and child-resistant packaging. This recommendation also applies to devices using synthetic nicotine.
3. That clinical testing, large population studies and full analyses of e-cigarette ingredients and manufacturing processes be conducted to determine their level of risk, viability, and efficacy as tools for tobacco cessation.
4. That e-cigarettes and other ENDS should never be marketed as a valid or efficacious method for smoking cessation without validated clinical research that is assessed by appropriate regulatory bodies. In all other instances, plain package marketing should be required, in accordance with the WMA Resolution on Plain Packaging of Cigarettes, e-Cigarettes and Other Smoking Product.
5. That the sale, marketing, distribution, and accessibility of e-cigarettes and other tobacco products to children and adolescents be prohibited.
6. That the production, distribution and sale of flavored e-cigarette cartridges and candy products that depict or resemble tobacco products be prohibited.
7. That the sale of e-cigarettes and ENDS via the internet be prohibited in order to prevent access to these products by minors.
8. That physicians, pediatric practitioners and dentists inform their patients of the potential risks of using e-cigarettes and ENDS, e.g., addiction, cardiovascular disease, lung disease, impact on brain development due to nicotine, physical injuries, etc., even if regulatory authorities have not taken a position on the efficacy and safety of these products.
9. That the WMA and its members support further research on the harmful effects of e-cigarettes and ENDS, especially in children, adolescents and young adults.



ข้อเรียกร้อง เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า

ข้อเรียกร้องเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า

<https://www.who.int/publications/m/item/electronic-cigarettes---call-to-action>

บุหรี่ไฟฟ้า¹ มีสารนิโคตินทำให้เสพติดรุนแรงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดบุหรี่ไฟฟ้าทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและรสชาติที่น่าดึงดูด โดยทำการตลาดเชิงรุกซึ่งมุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชน จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างกว้างขวางในหมู่เด็กและวัยรุ่น โดยมีอัตราการใช้สูงกว่าผู้ใหญ่ในหลายประเทศ

บุหรี่ไฟฟ้ามักถูกโฆษณาว่าเป็นทางเลือกที่มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบัน การค้า (การขาย การนำเข้า การจำหน่าย หรือการผลิต) บุหรี่ไฟฟ้าในฐานะสินค้าชนิดหนึ่งยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประโยชน์ทางสาธารณสุขในการช่วยเลิกบุหรี่มวน แต่กลับมีหลักฐานที่น่าตกใจเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพของประชากรเพิ่มมากขึ้น

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและเสพติดนิโคติน ควบคู่ไปกับการมีแนวทางที่ครอบคลุมในการควบคุมยาสูบที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ

ในกรณีที่ประเทศมีการห้ามการขายบุหรี่ไฟฟ้า ประเทศเหล่านั้นควรต้องการดำเนินการอย่างเข้มงวด รวมถึงมีมาตรการติดตามและเฝ้าระวังที่จะช่วยให้มีข้อมูลอัตราการใช้และรูปแบบการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังควรมีมาตรการเสริม เช่น การห้ามการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการให้ทุนสนับสนุน (รวมถึงการทำการตลาดดิจิทัล) และมีมาตรการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ประเทศมีการอนุญาตให้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์ ประเทศเหล่านั้นจำเป็นต้องมีกฎระเบียบที่เข้มงวด ซึ่งครอบคลุมประเด็นเหล่านี้เป็นอย่างน้อย

- ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดความน่าดึงดูดและอันตรายต่อประชากร ซึ่งรวมถึง:
 - การห้ามใช้สารปรุงแต่งรสทั้งหมด รวมถึงเมนทอลและสารสังเคราะห์เมนทอล

¹ คำว่าบุหรี่ไฟฟ้าใช้ในที่นี้เพื่ออ้างอิงถึงรูปแบบต่างๆ ของระบบการนำส่งนิโคตินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic nicotine delivery systems: ENDS) และระบบการนำส่งแบบไม่มีนิโคตินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic non-nicotine delivery systems: ENNDS) เช่น ไปป์อิเล็กทรอนิกส์ ชิชาอิเล็กทรอนิกส์ และซิการ์ไฟฟ้า เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ENDS และ ENNDS ทั้งหมด (เช่น รวมถึง e-liquid และอุปกรณ์) จะอยู่ภายในขอบเขตของข้อเรียกร้องฉบับนี้

- การห้ามใช้รูปลักษณะที่น่าดึงดูดและ/หรือรูปแบบการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ เช่น เช่น สีหรือคุณลักษณะของสี คำอธิบายที่น่าสนใจ รวมถึงชื่อ
 - การควบคุมคุณลักษณะที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการผลิตภัณฑ์ได้หลังการขาย
 - การจำกัดความเข้มข้นและปริมาณของนิโคติน เพื่อลดความเสี่ยงในการเสพติด
 - การกำหนดปริมาณสูงสุดสำหรับตลับบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อจำกัดการสัมผัสกับสารพิษ
 - การกำหนดพลังงานแบตเตอรี่สูงสุด เพื่อจำกัดการปล่อยนิโคตินและสารพิษ
 - การห้ามคุณสมบัติที่อนุญาตให้อุปกรณ์ส่งข้อมูลไปยังและจากบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้ผลิต) เช่น การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันโทรศัพท์ที่สามารถใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดของภูมิประเทศที่มีการใช้งาน หรือเพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์จากระยะไกล
 - การห้ามใส่สารเติมแต่งที่มีคุณสมบัติเป็นสารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธุ์ และเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
- ปกป้องสาธารณชนจากการกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวง เช่น การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพในการเลิกบุหรี่
 - ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็ก ควบคุมการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงที่เด็กจะเข้าถึง และบังคับใช้กฎระเบียบเหล่านี้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 - ปรับใช้มาตรการควบคุมยาสูบกับบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงการลดการผลิตและความต้องการตามแนวทางของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO FCTC)
 - เสริมสร้างการติดตามและการเฝ้าระวังเพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคและรูปแบบการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นปัจจุบัน (รวมถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าคู่กับบุหรี่ยาสูบ และการใช้ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆไปพร้อมกัน) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุม
 - เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎระเบียบ เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการข้างต้นมีประสิทธิภาพ
 - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับสาธารณะ

ไม่ว่าประเทศนั้นๆ จะห้ามการขายบุหรี่ไฟฟ้าหรืออนุญาตให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม การดำเนินมาตรการเหล่านี้ควรทำควบคู่ไปกับมาตรการสร้างแรงจูงใจและช่วยเหลือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เลิกใช้ยาสูบโดยใช้วิธีการที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การเลิกบุหรี่นั้นควรพิจารณาข้อมูลด้านประสิทธิภาพจากหลักฐานที่ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกันกับมาตรการควบคุมยาสูบอื่นๆ และอยู่ภายใต้การติดตามและประเมินผล จากหลักฐานวิชาการที่มีในปัจจุบัน ไม่แนะนำให้รัฐบาลอนุญาตให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่ รัฐบาลใดๆ ที่ดำเนินยุทธศาสตร์การเลิกบุหรี่โดยใช้นิโบริไฟฟ้าควรต้องควบคุมเงื่อนไขในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีภาวะบ่งชี้ทางคลินิกที่เหมาะสม และควบคุมผลิตภัณฑ์ในฐานะยา (รวมถึงการต้องได้รับอนุญาตทางการค้าว่าเป็นยา) การตัดสินใจใช้นิโบริไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์การช่วยเลิกบุหรี่ ถึงแม้จะอยู่ในรูปแบบที่ได้รับการควบคุมก็ควรเกิดขึ้นหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงปัจจัยต่างๆ เช่น บริบทของประเทศ ความเสี่ยงในการใช้นิโบริไฟฟ้า และกลยุทธ์การช่วยเลิกบุหรี่ปรูปแบบอื่นๆ ที่พิสูจน์แล้วว่ามมีประสิทธิภาพ

ข้อเรียกร้องฉบับนี้ องค์การอนามัยโลกจัดทำขึ้นจากการประเมินหลักฐานทางวิชาการที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานที่มีเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้นิโบริไฟฟ้าของเด็ก วัยรุ่น และผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ องค์การอนามัยโลกจะยังคงติดตามและประเมินหลักฐานเพิ่มเติมตามความจำเป็นต่อไป